

Répétitoire finalistes 2011

Psychiatrie générale de l'adulte

15 juin, 08h00-10h00

Dr P. Marquet

Un médecin généraliste est appelé auprès d'un patient de 28 ans, agité depuis quelques jours. Celui-ci l'accueille familièrement. Il dit qu'il l'a déjà rencontré et qu'il serait heureux de voir le médecin collaborer à la vaste campagne de promotion de la santé qu'il souhaite mettre en place. Il affirme avoir acheté ce jour une maison afin d'y implanter le siège social de son association ainsi que du matériel de bureautique et une voiture. Il a 3'000 francs en poche et souhaite sortir afin d'acheter des documents pour choisir les grandes orientations de son association. Sa famille dit qu'il ne dort plus depuis quelques jours, et que son comportement s'est largement modifié. Il était, il y a quelques semaines, plutôt calme et morose, réfléchissant beaucoup sur ce qu'il souhaitait faire de sa vie.

Quelles sont, parmi les classes médicamenteuses, celle qui risque d'être la plus efficace chez ce patient ?

- A. Antidépresseur sédatif
- ☒ B. Barbiturique
- C. Neuroleptique sédatif
- D. Benzodiazépine
- E. Régulateur de l'humeur

(Bonsack)

Sur quel constat sont basées les thérapies cognitivo-comportementales de la dépression ?

- A. Dans les modèles animaux, un paradigme d'impuissance acquise montre des éléments qui rappellent la dépression
 - B. Les individus déprimés ont souvent une anamnèse de pertes
 - C. Une période de stress précède habituellement les épisodes dépressifs
 - D. Un modèle d'agressivité retournée contre soi semble expliquer les symptômes chez beaucoup de patients déprimés
-  Beaucoup de patients déprimés ont des distorsions négatives de la pensée à propos d'eux-mêmes qui peuvent être modifiées dans le cadre d'un travail thérapeutique

(Bonsack)

Un homme de 49 ans avec une longue anamnèse de dépendance à l'alcool et de sans-abri insiste pour quitter immédiatement l'hôpital en raison d'obligations familiales et professionnelles pressantes. Quel est l'élément le plus probable que vous allez trouver à l'examen clinique ?

- A. Des hallucinations auditives
- B. Des symptômes dépressifs
- C. Des symptômes maniaques
- ☒ D. Des troubles de la mémoire
- E. Des troubles de la conscience

(Bonsack)

La raison la plus importante de contrôler régulièrement les taux sanguins de lithium est:

- A. pour vérifier la compliance du patient
- ☒ B. parce que la dose toxique est proche de la dose thérapeutique
- C. parce que le lithium est rapidement excrété dans les urines
- D. parce que le lithium est un sel minéral
- E. aucune des raisons ci-dessus

(Bonsack)

Quel est le symptôme qui permet le mieux de faire la différence entre une dépression et des variations de l'humeur liées à un trouble de la personnalité borderline?

- A. Humeur dépressive
 - B. Irritabilité
 - C. Idées suicidaires
 - D. Sentiment de vide
-  Impulsivité

(Despland)

Quel est le symptôme le plus spécifique d'un état anxieux par rapport à un état dépressif?

- A. Fatigue
- B. Troubles du sommeil
- C. Troubles de l'appétit
- D. Plaintes somatiques
- ☒ Vécu de dépersonnalisation

(Despland)

Quel est la fourchette de prévalence sur la vie de l'épisode dépressif majeur chez l'homme (sexe masculin)?

- A. 0-4%
- B. 4-12%
-  C. 12-16%
- D. 16-20%
- E. >20%

(Despland)

Parmi ces facteurs de risque, quel est celui qui est **le moins spécifique** de la dépression postnatale ?

- A. Anamnèse de dépression(s) antérieure(s)
 - B. Relation conjugale conflictuelle
 - C. Manque de soutien social
 - D. Environnement difficile (facteurs de stress)
-  Trouble de la personnalité

(Despland)

Madame A. est une jeune patiente de 26 ans, qui est en 5^{ème} année de médecine. Elle consulte son médecin généraliste en raison d'un épisode dépressif d'intensité moyenne sans symptômes psychotiques (7 critères sur les 9 pour l'Episode Dépressif Majeur), qui a débuté 1 mois auparavant, suite à une rupture amoureuse. Elle n'a pas d'idées suicidaires. Elle n'a pas d'antécédents psychiatriques. Elle décrit des relations familiales assez froides et distantes et signale que ses parents sont en train de divorcer. Quelle est l'attitude la plus pertinente?

- A. La rassurer sur le fait que sa réaction est normale et lui dire de téléphoner si les symptômes persistent
-  B. Souligner qu'elle est déprimée et lui proposer un deuxième entretien dans une semaine pour faire le point
- C. Débuter un traitement antidépresseur (SSRI)
- D. Lui proposer un consilium psychiatrique pour évaluer la pertinence d'une psychothérapie
- E. Lui proposer de la voir avec ses parents

(Despland)

Une femme de 25 ans a été hospitalisée suite à une tentative de suicide. Cette femme a déclaré qu'elle pleurait souvent pendant les deux derniers mois et qu'elle a commencé depuis lors à se désintéresser de ses amis et des activités sociales. Elle déclare aussi avoir d'importants troubles du sommeil. C'est un premier épisode. Quel est le traitement qui est le plus adéquat parmi ceux proposés ci-dessous?

- A. Antidépresseur tricyclique sédatif
- B. Stabilisateur de l'humeur, et si besoin, pendant une courte période, une benzodiazépine ou apparenté
- ☒ C. Antidépresseur du type inhibiteur de la recapture de la sérotonine, et si besoin, pendant une courte période, une benzodiazépine ou apparenté
- D. Neuroleptique sédatif
- E. Benzodiazépine ou apparenté

(Eap)

Chez un patient recevant un traitement par un antidépresseur pour un premier épisode dépressif, quelle devrait être la durée du traitement?

- A. Au minimum 1 année après que le patient a commencé à répondre au traitement
- B. Au minimum 1 année après la rémission
- ☒ C. Au minimum 6 mois après la rémission
- D. Au minimum 2 ans après le début de l'épisode dépressif
- E. Au minimum 1 année après le début de l'épisode dépressif, mais si possible 2 ans

(Eap)

Une semaine après l'introduction de sertraline (un inhibiteur de la recapture de la sérotonine) chez une patiente pour un épisode dépressif majeur, celle-ci se plaint qu'il n'y a aucune amélioration, et que ses insomnies se sont même péjorées. Quelle stratégie vous semble la plus adéquate ?

- A. Ne rien changer, rappeler à la patiente que la réponse au traitement va prendre du temps (2 à 3 semaines après le début du traitement)
- B. Ne rien changer, rappeler à la patiente que la réponse au traitement va prendre du temps (4 à 8 semaines après le début du traitement)
- C. Remplacer la sertraline par un antidépresseur tricyclique sédatif
Rappeler à la patiente que la réponse au traitement va prendre du temps (2 à 3 semaines après le début du traitement), et prescrire pour la plus courte période possible un sédatif (benzodiazépine ou apparenté)
- E. Rappeler à la patiente que la réponse au traitement va prendre du temps (4 à 8 semaines après le début du traitement), et prescrire pour la plus courte période possible un sédatif (benzodiazépine ou apparenté)

(Eap)

Chez un patient ne répondant pas à un traitement antidépresseur (60 mg/j de citalopram, un inhibiteur de la recapture de la sérotonine), une combinaison de deux médicaments est prévue, pour tenter d'augmenter la réponse antidépressive. Laquelle de ces combinaisons est à éviter absolument car pouvant augmenter de façon importante le risque d'un syndrome sérotoninergique?

- A. Citalopram et venlafaxine, un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine
- ☒ B. Citalopram et moclobémide, un inhibiteur de la monoamine oxydase
- C. Citalopram et lithium, un stabilisateur de l'humeur
- D. Citalopram et quetiapine, un antipsychotique
- E. Citalopram et mirtazapine, un antidépresseur sérotoninergique et noradrénergique

(Eap)

Lors de l'arrêt d'un traitement antidépresseur avec un inhibiteur de la recapture de la sérotonine ou un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et noradrénaline, il est recommandé si possible de baisser progressivement la dose de l'antidépresseur sur quelques semaines. Pour quelle raison ?

- A. Pour éviter un effet rebond de la dépression
- ☒ B. Pour éviter un syndrome de sevrage sérotoninergique
- C. Pour éviter le risque de dépendance
- D. Pour ne pas inquiéter le patient par un arrêt trop brusque de la prescription
- E. Aucune des raisons ci-dessus

(Eap)

Une patiente de 23 ans, d'apparence soignée, consulte en urgence son médecin généraliste pour une symptomatologie dépressive. Elle se met à pleurer immédiatement et explique qu'elle se sent mal depuis quelques jours, suite à un conflit avec son chef qu'elle trouve trop exigeant et peu compréhensif. Sans avertir son patron, elle n'est pas retournée au travail parce qu'elle se sentait trop fatiguée et déprimée et affirme sur un ton désespéré ne plus pouvoir y retourner. Parmi les attitudes ci-dessous, laquelle est **la moins** pertinente ?

- A. Le médecin traitant fait un arrêt de travail d'une semaine et lui propose de prendre contact avec son patron pendant ce temps-là.
-  B. Le médecin traitant prescrit un antidépresseur de type SSRI.
- C. Le médecin traitant suspend toute décision et lui propose un nouveau rendez-vous pour rediscuter plus en détail de tout cela dans 2 jours.
- D. Le médecin traitant explique qu'il ne fait pas de certificat de travail rétroactif et renvoie la patiente à ses responsabilités en lui rappelant les conséquences potentielles de son comportement.
- E. Le médecin traitant suspecte un trouble de la personnalité et prend contact avec son confrère psychiatre-psychothérapeute.

(Marquet)

Vous constatez chez votre patient des épisodes dépressifs modérés et sévères alternant avec des épisodes hypomaniaques. Quel diagnostic retenez-vous ?

- A. Un trouble dysthymique
- B. Un trouble cyclothymique
- ☒ C. Un trouble bipolaire type II
- D. Un trouble bipolaire type I
- E. Un trouble schizoaffectif

(Marquet)

Concernant les troubles de l'humeur, laquelle de ces propositions est **fausse** ?

-  La transmission génétique joue un rôle plus élevé dans les troubles unipolaires que bipolaires
- B. La prévalence des troubles bipolaires est moins élevée que celle du trouble unipolaire
- C. Des troubles anxieux tels que des attaques de panique sont des comorbidités fréquentes des troubles bipolaires
- D. L'abus de substances psychotropes est une comorbidité fréquente des troubles bipolaires associée à un risque suicidaire augmenté
- E. Les thymorégulateurs représentent la base du traitement pharmacologique des troubles bipolaires

(Marquet)

Une jeune patiente de 27 ans, souffrant d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, que vous suivez depuis longtemps, vous décrit avoir eu la veille pour la première fois des hallucinations visuelles. Laquelle de ces propositions est **fausse ou inadéquate** ?

- A. Vous suspectez une prise de substance psycho-active et questionnez la patiente à ce sujet.
-  B. Les hallucinations visuelles sont habituelles dans le diagnostic de trouble de la personnalité borderline, dans des circonstances de stress aigu.
- C. Ces hallucinations visuelles vous inquiètent, et vous réfléchissez à l'organisation d'un éventuel bilan organique (imagerie cérébrale, peut-être EEG).
- D. Vous recherchez une consommation chronique d'alcool ou de benzodiazépines chez la patiente, et la notion d'un sevrage récent.
- E. Vous faites un status psychiatrique et neurologique complet.

(Marquet)

Vous recevez dans votre cabinet une jeune patiente de 30 ans, sans antécédents particuliers. Celle-ci vous décrit une rupture sentimentale difficile pour elle, il y a une semaine. Elle évoque souffrir depuis d'une tristesse accompagnée de pleurs, ruminations anxieuses, aboulie, anhédonie, troubles du sommeil et de l'appétit. La patiente, angoissée, vous demande un traitement. A l'issue de votre entretien, vous fixez un nouveau rendez-vous dans une semaine, et vous entendez avec elle en attendant jusque-là sur la mise en place :

- A. D'un traitement antidépresseur, type inhibiteur de la recapture de la sérotonine.
 - B. D'un traitement antidépresseur, type tricyclique.
 - C. D'un traitement stabilisateur de l'humeur, type lithium.
 - D. D'un traitement neuroleptique sédatif, tel que la quetiapine.
-  D'un traitement anxiolytique, type benzodiazépine.

(Marquet)

Un patient de 40 ans se rend à la consultation d'un médecin généraliste car il se sent soudainement fatigué, sans énergie. Ralenti et peu communicatif, il raconte répétitivement qu'il se serait récemment endetté et aurait trompé son épouse. Il se sent très coupable et pense au suicide. Quelle est la prochaine mesure à prendre ?

- A. Hospitalisation en psychiatrie
- ☒ B. Investigation plus approfondie de la suicidalité
- C. Prescription d'une benzodiazépine
- D. Contrat de non-suicide
- E. Appeler l'épouse

(Preisig)

Une femme de 35 ans s'est rendue plusieurs fois aux urgences suite à l'apparition brusque de dyspnée, de tachycardie, de tremblements et de sudations. Les investigations somatiques n'ont pas mis en évidence d'origine organique. Quel traitement **n'est pas** indiqué ?

- A. Psychothérapie
- B. Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine
- C. Benzodiazépine
- ☒ D. Neuroleptique sédatif
- E. Clomipramine

(Preisig)

Un patient de 23 ans est traité par un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine pour son premier épisode dépressif. L'évolution est favorable et le patient relate, lors d'une consultation, que son énergie est revenue. Il sort beaucoup et il n'a presque plus besoin de dormir pendant la nuit. Quelle mesure thérapeutique immédiate est indiquée ?

- ☒ A. Arrêter l'antidépresseur
- B. Ajouter un stabilisateur de l'humeur à l'antidépresseur
- C. Remplacer l'antidépresseur par un stabilisateur de l'humeur
- D. Ajouter un neuroleptique à l'antidépresseur
- E. Remplacer l'antidépresseur par un neuroleptique classique

(Preisig)

Une patiente désespérée de 29 ans se rend à la consultation de son médecin. Elle a beaucoup de mal à quitter sa maison car elle doit contrôler de façon répétitive si la porte de la maison est bien fermée. Sur le plan du diagnostic différentiel laquelle des investigations suivantes vous aide **le moins** ?

- A. Investigation de la présence d'hallucinations auditives
- B. Anamnèse familiale de troubles obsessionnels-compulsifs
-  C. Consommation d'alcool ou de drogue
- D. Anamnèse de pensées obsessionnelles
- E. Investigation de la personnalité de la patiente

(Preisig)

Laquelle des affirmations suivantes est correcte concernant le traitement d'un épisode dépressif ?

- A. La pharmacothérapie est plus efficace que la psychothérapie pour le traitement d'épisodes dépressifs de sévérité modérée
- B. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine induisent souvent une prise de poids
- C. Les neuroleptiques sédatifs peuvent être indiqués pour calmer une dépression
-  D. Le lithium peut potentialiser l'effet des antidépresseurs
- E. Un antidépresseur n'a pas d'effet préventif lorsqu'il est administré à long terme

(Preisig)